

Deutsche Rentenversicherung Nord - Sozialmedizinisches Gutachten

Gutachter: Dr. med. Wolf-Dieter Brunsbüttel, FA für Innere Medizin und Sozialmedizin

Untersuchung: 27.02.2026, 09:30 bis 11:10 Uhr (100 Minuten)

Versicherter: Bodo Petersen, geb. 11.05.1964, Beruf bis 2023: Maurer

Anamnese

Der Versicherte berichtet über seit 2018 zunehmende Rückenschmerzen, insbesondere LWS-Bereich. 2020 erstmals Lumbago, 2023 Bandscheibenvorfall L5/S1, OP im März 2023 (Kiel-Wellingdorf). Nach OP zunächst Besserung, ab Sommer 2024 erneut Beschwerden, jetzt belastungsabhängig, mit Ausstrahlung in beide Beine.

Daneben besteht laut Versichertem seit Ende 2024 eine depressive Erkrankung mit Erschöpfung, Schlafstörung, Antriebsmangel; Behandlung bei Dr. Edda Lornsen-Joost (Fachärztin Psychiatrie und Psychotherapie) seit November 2024. Aktuelle Medikation Citalopram 20 mg.

Untersuchungsbefund

Schlanker Versicherter in altersentsprechendem Allgemeinzustand. LWS-Klopfschmerz, eingeschränkte Beweglichkeit der LWS (Finger-Boden-Abstand 35 cm). Lasègue-Zeichen links bei 60 Grad positiv, rechts negativ. Periphere DMS unauffällig. Kein motorisches Defizit. Psychischer Befund: niedergeschlagen, jedoch im Gespräch zugewandt, Konzentration durchgehend ausreichend, keine Suizidalität.

Diagnosen

M54.5 Kreuzschmerz - M51.1 Lumbale Bandscheibenschäden mit Radikulopathie - F32.1 Mittelgradige depressive Episode - Z.n. NPP-OP L5/S1 (03/2023)

Sozialmedizinische Beurteilung

Die Erwerbstätigkeit als Maurer ist dem Versicherten dauerhaft nicht mehr möglich (schweres Heben, Zwangshaltungen).

Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sehe ich den Versicherten in einer angepassten Tätigkeit (leichte Arbeiten, überwiegend sitzend, wechselnde Körperhaltung, ohne häufiges Bück- und Hebearbeit, ohne erheblichen Zeitdruck) noch in der Lage, 3 bis unter 6 Stunden täglich zu arbeiten.

Die depressive Episode wird unter laufender Behandlung als grundsätzlich besserungsfähig eingestuft. Eine vollständige Aufhebung des Leistungsvermögens für leichte Tätigkeiten ist aus internistisch-sozialmedizinischer Sicht nicht begründbar.

Empfehlung: Bewilligung Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung auf Zeit (zwei Jahre).

Dr. Brunsbüttel